

23. L'hypoglycémie chez le diabétique : (P2 2024 T37)

- 1- Est définie par une glycémie inférieure à 0,50g/l.
- 2- Peut-être non ressentie chez le sujet âgé.
- 3- Peut aggraver une rétinopathie diabétique.
- 4- Elle est sévère et prolongée chez les patients traités par Metformine.
- 5- La prise d'alcool peut être un facteur déclenchant de l'hypoglycémie chez le diabétique.

A: 1-3-5 B: 2-3-4 C: 2-3-5 D: 4-5 E: 1-2-3

C 1-glycémie inférieure à 0,5 g/l définit le coma hypoglycémique

-L'hypoglycémie se définit par la glycémie au-dessous de laquelle apparaissent les manifestations cliniques

Neurogènes d'alarme soit 0,6 - 0,65 g/l.

2-L'hypoglycémie peut-être non ressentie chez le sujet âgé par la présence des complications dégénératives sous forme des neuropathies végétatives

3-Car la pression de perfusion est maintenue artificiellement grâce à la pression osmotique. Si cette dernière baisse trop rapidement, une ischémie peut survenir et aggraver la néovascularisation

5- l'alcool déclenche une hypoglycémie par l'inhibition de voie de néoglucogenèse hépatique

24. La cétoacidose diabétique : (P2 2024 T36)

- 1- Est définie par l'association d'une hyperglycémie, présence d'acétonémie avec un PH artériel inférieur à 7,3.
- 2- L'insulinothérapie parentérale est contre-indiquée si la Kaliémie est inférieure à 3,3 mmol/l.
- 3- Le facteur déclenchant infectieux est représenté le plus souvent par les infections pulmonaires et urinaires.
- 4- Survient surtout dans un contexte d'insulinopénie relative.
- 5- L'hyponatrémie témoigne de la présence d'une déshydratation intracellulaire.

A: 1-2-3-5 B: 1-2-3 C: 3-4-5 D: 2-3-4 E: 1-2-3-4-5

A -L'acidocétose diabétique survient chez les diabétiques de type 1 (insulinopénie absolue) et est moins fréquente chez les diabétiques de type 2 (Insulinopénie relative)

-L'hyponatrémie est due à une dilution en rapport avec l'hypertonie plasmatique induite par l'hyperglycémie. Elles s'associent donc à une déshydratation intracellulaire

25. L'état hyperosmolaire : La ou les réponses justes (P2 2024 T35)

- 1- Est défini par une hyperglycémie majeure associée à une osmolarité plasmatique qui dépasse les 350 mosm/ kg d'eau
- 2- Survient surtout chez le sujet âgé grabataire

- 3- La présence de cétose est obligatoire pour le diagnostic
4- Survient surtout chez les patients traités par insulinothérapie que chez ceux traités par antidiabétique oral.
5- L'existence d'une insulino-pénie absolue est un élément nécessaire pour sa survenue.

A: 1-2 B: 1-4 C: 2-3 D: 2-4 E: 4-5

A Rappel:

Le coma hyperosmolaire est une forme grave de décompensation du diabète sucré, la mortalité étant de 20 à 30 % du fait des complications secondaires, iatrogène et du terrain fragile sous-jacent. Il est défini par :
-Une hyperglycémie > 6g/l.

- Osmolarité calculée > 350mos/l (N = 290-320).
- Déshydratation majeure.
- Troubles de la conscience.
- Cétonémie ou cétonurie négative.

• **Terrain :**

- Diabète de type 2 peu important (Insulinosécrétion conservée).
- Diabète non connu ou négligé.
- Sujet âgé : Dépendance de l'entourage, troubles neuropsychiatriques, perte de la sensation de soif,
- Incapacité de boire : Débilité, démence, âge avancé, handicap mental...

• **Facteurs favorisants:**

- **Age > 70 ans** (perte ou diminution de la sensation de soif+++)
- Démence
- Résidence en maison de retraite
- Diabète méconnu
- **Diabète non traité par insuline**
- Facteurs médicamenteux:
diurétiques,corticoides,immunosuppresseurs,nutrition parentérale.

Le jeune BM, âgé de 17 ans, diabétique de type 1 depuis 10 ans, traité par un schéma insulinaire basal bolus, arrive aux urgences suite à un malaise brutal. Sa tension artérielle est de 120/75 mmHg, son pouls 95 pulsations/ mn. Le bilan réalisé, montre : une glycémie à 1 g/l, une glycosurie -, une acétonurie +.

26. Vous pensez d'abord à : (P2 2024 T)

- A- Une céto-acidose débutante.
- B- Une acidose lactique
- C- Une hypoglycémie
- D- Une hypotension
- E- Un trouble du rythme cardiaque.

- C Tout symptôme brutal, inhabituel chez un patient diabétique sous traitement hypoglycémiant (insuline,
SH) est une hypoglycémie jusqu'à preuve du contraire

27. Parmi ces manifestations, une hypoglycémie est évoquée devant: (Réponse fausse) (P1 2024 T34)

- A. Pâleur.
- B. Convulsions
- C. Sueurs.
- D. Soif
- E. Diplopie

34 D-La Clinique de l'hypoglycémie :

symptômes neurovégétatifs

-mains moites, sueurs froides, pâleur tremblements des extrémités, tachycardie avec palpitations, sensation de **faim intense**(*la soif on la trouve surtout dans l'acédocétose*)

-symptômes moins fréquents: poussées hypertensives, crises d'angor , troubles du rythme, nausées, vomissements

symptômes neuroglycopéniques si glycémie < 0,50 g/l

-Flou visuel , céphalées, malaise asthénie importante, troubles de la concentration, troubles psychiatriques, troubles moteurs déficitaires, **visuels**....

En l'absence de resucrage : **coma brutal** avec tachycardie, sueurs abondantes, sd pyramidal, Babinski bilatéral...(agitation).

28. Le coma hyperosmolaire (La ou les réponses justes) (P1 2024 T28)

- A. Est souvent observé chez le sujet dément
- B. Associe une hyperglycémie supérieure à 3 g/L.
- C. Entraîne un enfoncement oculaire et une sécheresse des muqueuses.
- D. Associe une hypercétonémie.
- E. Est associé à un taux élevé mortalité

28 ABCE -Complication métabolique **grave** du diabète type II (notamment sujet âgé (dément surtout))

-caractérisée par l'association :

-d'une hyperglycémie sévère (sup à 3g/l) sans cétose

-d'une déshydratation majeure globale

-troubles de la conscience

-Hyperosmolarité plasmatique

29. L'acidocétose diabétique: (La réponse juste) (P1 2024 T27)

- A. Est aussi appelée coma hyperosmolaire
- B. Est causée par un excès de glycogène dans le sang.
- C. Son traitement est basé seulement sur l'insuline et du sérum

physiologique

D. Un de ses symptômes est la polypnée.

E. Son facteur déclenchant est toujours une infection.

27 D

- Parmi ses symptômes , on trouve la Dyspnée de Kussmaul associée à une polypnée (pour compenser l'acidose)

**Dans le coma hyperosmolaire, toutes ces anomalies .30
sont présentes sauf une: (Cochez la réponse fausse)
(RATT 2023 T35)**

A- Trouble de la conscience

B- Une hyperglycémie massive

C- Hypermnatrémie

D- Une glycosurie et cétonurie massive

E- Une déshydratation

D	Le coma hyperosmolaire associe : -d'une hyperglycémie sévère sans cétose -d'une déshydratation majeure -troubles de la conscience -Hyperosmolarité plasmatique $>320\text{mosm/l}$ (N = 290-320)
---	---

**Les symptômes suivants sont observés au cours de .31
l'acidocétose diabétique, sauf: (Cochez la réponse fausse)
(RATT 2023 T34)**

A. Les nausées et vomissements

B. La dyspnée de Kusmaul

C. L'hypothermie

D. Un Babinski bilatéral

E. Les douleurs abdominales diffuses

D	Le babinski bilatérale est retrouvé dans le coma hypoglycémique
---	---

**32. Le syndrome Hyperglycémique Hyperosmolaire se caractérise par toutes ces proposition
sauf : (P3 2023 T34)**

1. Une glycémie $>6\text{g/l}$

2. Une osmolarité entre 300 et 310mosmol/l

3. $\text{PH} < 7,20$

4. Le risque thrombo-embolique est fréquent

5. La mortalité est élevée

Propositions :

A: 1+2

B: 2+3

C: 2+3+4

D: 3+4+5

E: 1+2+4

34 B Le syndrome Hyperglycémique Hyperosmolalre se caractérise par :

- D'une hyperglycémie sévère sans cétose $>6\text{g/l}$
- D'une déshydratation majeure
- Troubles de la conscience
- Hyper osmolarité plasmatique $>320\text{mosm/l}$
- mortalité 20 à 50 % .